austria wirtschaftsservice aws

ANAMNIC

Telefonbasierte Voice-KI für strukturierte, barrierearme medizinische Anamnese vor dem Arztgespräch.

Peter Fehringer, BSc. MSc.
aws Preeseed – Innovative Solutions
März 2026

Inhalt

01 Problemstellung
02 Lösung / impactspezifische Innovation
03 Use Cases
04 USP / Alleinstellungsmerkmal
05 Impact / gesellschaftlicher Mehrwert
06 Geschäftsmodell
07 Markt
08 Mitbewerb & Umfeld
09 Team
10 Kooperationen
11 Status Quo & Next Steps
12 Herausforderungen & Risiken
13 Vision & Wachstum
14 Quellen

Problemstellung

Zeitkrise im System

51,6 % der ärztlichen Arbeitszeit entfällt auf Administration. [1]

Konsultationsdauer in Österreich beträgt im Schnitt nur **5 Minuten** (EU-Schlusslicht). [2]

Anamnese erfolgt oft unter massivem Zeitdruck auf Kosten der Behandlungsqualität.

Digitale Exklusion

Bestehende digitale Lösungen sind primär formularbasiert.

23 % der über 65-Jährigen nutzen kein Smartphone regelmäßig. [3]

Menschen mit Lese-/Schreibschwierigkeiten, Seh- oder motorischen Einschränkungen werden durch schriftliche Formulare benachteiligt.

Daraus folgt:
Zeitmangel in der medizinischen Versorgung und digitale Ausschlüsse gefährden den Zugang breiter Bevölkerungsteile zu qualitativer Gesundheitsversorgung.
Aktuelle digitale Standardlösungen verlagern den Aufwand oft auf die Patient:innen und schaffen so neue Zugangsbarrieren.

Lösung / impactspezifische Innovation (1)

1. Automatisierter Anruf

Patient:in wird vor dem Termin vom System angerufen.

2. KI-Gespräch

Strukturierte, empathische Abfrage der Symptome in natürlicher Sprache.

3. Praxis-Bericht

Daten liegen vor dem Termin strukturiert (und exportierbar) bereit.

Für Patient:innen:
- Einfach erzählen
- keine Formulare
- unkompliziertes Nachfragen
- kein Smartphone nötig

Für Ärzt:innen:
- Strukturierte Infos vor dem Termin
- gezielte Rückfragen statt Grunderhebung
- mehr Zeit für Medizin

Lösung / impactspezifische Innovation (2)

Technologie ist reif

LLMs ermöglichen natürliche deutschsprachige Gespräche.

Markt ist bereit

Voice-AI im Healthcare wächst jährlich um 37,79%. [9]

Politischer Rückenwind

eHealth-Strategie 2024–2030
(51 Mio. EUR/Jahr) [8]

PVE-Ausbau mit 100 Mio. EUR EU-Förderung [14]

Problem verschärft sich

Ärztemangel nimmt zu.

Konsultationszeiten werden kürzer, Administrationslast steigt weiter. [6, 12, 13]

Use Case (1)

Persona

Herr Maier, 80 Jahre

Nutzt sein Smartphone kaum.

Hat Beschwerden, möchte aber keine langen Formulare am Bildschirm lesen oder ausfüllen.

Patient Journey

1. Termin wird in der PVE vereinbart.
2. Anamnic ruft Herrn Maier am Telefon an.
3. Die KI fragt in verständlichem Tempo nach Beschwerden und Medikation.
4. Der Arzt startet mit einem strukturierten Vorab-Bild in den Termin.

Daraus folgt:
Deutlich verbesserte Inklusion ohne technischen Schulungsaufwand für Patient:innen
Barrierearmer Zugang im Alter – Technik, die sich den Nutzer:innen anpasst

Use Case (2)

Persona

Amina, 35 Jahre

Fühlt sich krank, verunsichert und emotional belastet.

Deutsch ist nicht ihre Muttersprache; medizinische Formulare unter Stress überfordern sie.

Patient Journey

1. Gespräch statt Formular: Anamnic führt ruhig durch die Fragen.
2. Verständliche Rückfragen sichern die Qualität der Angaben ab.
3. Optional mehrsprachige Gesprächsführung baut Hürden ab.
4. Der Arzt erhält einen strukturierten, sprachlich vereinheitlichten Bericht.

Daraus folgt:
Ein sprachbasierter Zugang ist in Belastungssituationen deutlich geeigneter als ein Schriftstück.
Sicherheit bei sprachlichen und emotionalen Hürden.

USP / Alleinstellungsmerkmal

	Schrift / Formular	Sprachbasiert
Vor dem Termin	Idana Nelly CGM	ANAMNIC
Während/Nach dem Termin	Herkömmliche Anamnese	Tandem Health

Telefonkanal
Umgeht Hardware- und App-Pflichten.

Barrierearm
Sprache statt Schrift fördert Inklusion.

Vorbereitend
Praxisnutzen entsteht vor dem Gespräch, nicht erst als Mitschrift währenddessen.

Schutzrechtsstrategie:
Schutz aktuell primär über First-Mover-Vorsprung, proprietäres Prozess-Know-how und Integrationskompetenz.
Spätere Prüfung formaler Schutzrechte bleibt eine Option.

Impact / gesellschaftlicher Mehrwert (1: Tiefe)

82,5%

der ärztlichen Diagnosen basieren maßgeblich auf der Anamnese. [4]

bis zu 40%

potenzielle Zeitersparnis bei der Dokumentationsarbeit. [5]

52.000+

Berufsärzt:innen in Österreich als potenzielle Nutznießer. [6]

Die Wirkung im System

- Strukturierterer Gesprächsbeginn und weniger redundante Abfragen
- Bessere Fokussierung auf die medizinisch relevanten Details
- Reduktion der administrativen Überlastung in Ordinationen
- Bessere Anamnese → fundiertere Diagnose → effizientere Versorgung → breiterer Zugang

Impact / gesellschaftlicher Mehrwert (2: Reichweite)

Bisher oft benachteiligt

- Ältere Menschen ohne regelmäßige Smartphone-Nutzung
- Menschen mit Lese- oder Schreibschwierigkeiten
- Personen mit Seh- oder motorischen Einschränkungen
- Patient:innen in emotionalen Ausnahmesituationen

Erweiterter Zugang durch Anamnic

Sehr breites Zugangspotenzial über den universellen Telefonkanal – insbesondere für ältere Menschen, sprachlich benachteiligte Gruppen und Personen mit eingeschränkter digitaler Routine.

Sprache senkt die Hürde in Belastungssituationen signifikant.

Daraus ergeben sich die Themenfelder:
Diversität | Gleichstellung | Integration | Inklusion beziehungsweise **Gesundheit | Pflege**

Wirkungstreppe

7	**Gesellschaft verändert sich:** Nachhaltige Entlastung des Gesundheitssystems	IMPACT
6	**Lebenslage ändert sich:** Bessere Konsultationen, barrierefreier Zugang	
5	**Zielgruppen ändern Handeln:** Praxen verlagern Anamnese systematisch vor den Termin	
4	**Bewusstsein/Fähigkeiten ändern sich:** Ärzte erkennen Wert vorgelagerter Anamnese	OUTCOME
3	**Zielgruppen akzeptieren Angebote:** Ärzte integrieren Berichte, Patienten akzeptieren Voice-KI	
2	**Zielgruppen werden erreicht:** Pilotpraxen nutzen Anamnic, Patienten nehmen Anrufe an	OUTPUT
1	**Aktivitäten finden statt:** MVP entwickelt, Pilotbetrieb gestartet	

Geschäftsmodell

Starter

ab 150 €/Mo.

Für Einzelpraxen
Basis-Features
bis 100 Anrufe/Monat

Professional

ab 300 €/Mo.

Für Gemeinschaftspraxen
erweitertes Volumen
strukturierter PVS-Export (HL7, FHIR, …)

Enterprise

auf Anfrage (auf Anfrage (Ø ~ 720 €/Mo.))

Für PVEs / Kliniken
Multi-User
individuelle Anpassungen

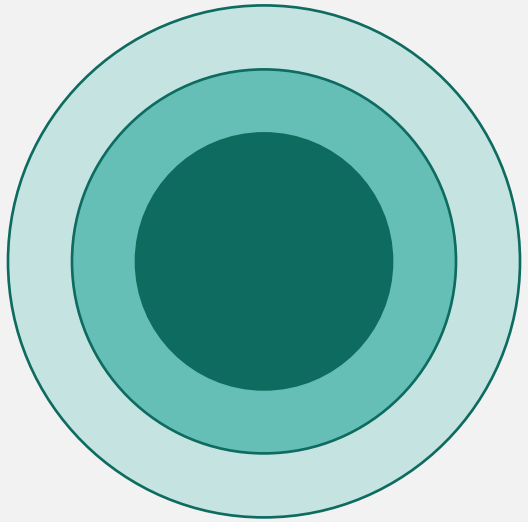
Skalierbarkeit

cloudbasiert
keine zusätzliche Hardware beim Kunden nötig
technologisch bedarfsgesteuert skalierbar

Vertriebsstrategie

Direct Sales fokussiert auf größere Einrichtungen (PVEs)
→ begleitete Pilotphase (30–60 Tage)
→ Conversion in langfristige Verträge

Markt



TAM (DACH)
Gesamter adressierbarer Markt für eHealth-/Praxissoftware-Erweiterungen (~250 Mio. €) [9]

SAM (Österreich)
Realistischer Zielmarkt in AT (~30 Mio. €) [10]

SOM (Markteintritt)
Fokussegment erste 4 Jahre (~228.000 €) [11]

Zielgruppe Markteintritt:
Primärversorgungseinheiten (PVEs) und stark frequentierte Kassen-Gemeinschaftspraxen

Marktdynamik:
Rückenwind durch Ärztemangel, nationale eHealth-Strategie [8] und den European Health Data Space (EHDS) [7]

Mitbewerb & Umfeld

Kriterium	Idana / Nelly	CGM (Ambulapps)	Tandem Health	ANAMNIC
Vor dem Termin ansetzend	Ja	Ja	Nein	**Ja**
Sprachbasiert (Voice)	Nein	Nein	Ja	**Ja**
Barrierearm (ohne App/Smartphone)	Nein	Nein	Ja	**Ja**
Vorstrukturierend für die Praxis	Ja	Ja	Teilweise	**Ja**
Inklusiver Zugang (Alter, Sprache)	Nein	Nein	Nein	**Ja**

Die Wettbewerbslandschaft differenziert sich stark bei den Faktoren Zeitpunkt und Zugänglichkeit.

Formular-Lösungen (Idana, Nelly) setzen vor dem Termin an, sind aber nicht sprachbasiert. CGM (Ambulapps) digitalisiert Praxisprozesse, bleibt aber formularbasiert. Scribing-Tools (Tandem Health) sind sprachbasiert, setzen aber erst während des Termins an. Anamnic verbindet „vorab“ mit „Sprache“.

Der Vorsprung liegt in einer veränderten Zugangsarchitektur mit höherem Impact-Potenzial für benachteiligte Gruppen.

Team

Peter Fehringer

Gründer

Vorhabenspezifische Qualifikationen

MSc Data Science & Engineering:
Know-how im Bereich LLMs, NLP und Datenarchitekturen
Masterarbeit im Bereich European Health Data Space

BSc Medizininformatik:
Tiefes Verständnis für FHIR, HL7 und ELGA/EHDS.
Verbindung aus technischer Umsetzungsfähigkeit und regulatorischem Systemverständnis.

Geplante zusätzliche Rollen:

- Medizinische Fachberater:innen
- Juristischer Beratung (Regulatorik)
- Entwicklungs-Ressourcen im späteren Wachstum

Kooperationen

Pilotpraxen / Pilotkund:innen

Rolle: Iteratives Testen und Feedback im Echtbetrieb
Basis: LOIs (Letter of Intent) in Anbahnung

Medizinische Fachberatung

Rolle: Fachliche Validierung der KI-Gesprächsführung
Basis: Beratende Begleitung der Pilotphase

IT- & Medizinrecht

Rolle: Regulatorische Sicherheit (MDR-Abgrenzung, DSGVO-konforme Architektur)
Basis: Externe Dienstleister / Kanzleien

Strategische Technologie-Enabler

Rolle: Robuste Infrastruktur (Telefonie, Hosting, Sprachmodelle)
Basis: Vorhandene Infrastrukturpartner (z.B. sipgate, Cloud-Provider)

Fokus:
Validierungspartner aus der medizinischen Praxis und rechtliche Absicherung

Status Quo & Next Steps

Bereits abgeschlossen

- ✓ Konzept- und Architekturphase.
- ✓ Technische Machbarkeit verifiziert (STT, LLM, Telefonie-APIs)
- ✓ Regulatorische Ersteinordnung vorgenommen
- ✓ Business- und Finanzplanung strukturiert

Nächste Schritte

Q2/Q3 2026:
Förderanträge, Gründung, Sicherung von LOIs

Q3/Q4 2026:
Entwicklung Backend / Gesprächslogik, Fertigstellung des MVPs

Q1/Q2 2027:
Pilotbetrieb und Erhebung von Praxisdaten

Fokus:
Konzept und Architektur sind erarbeitet – der Fokus liegt auf MVP und Pilotierung

Meilensteine:
MS1: Fördervertrag → MS2: Demo-MVP & LOIs → MS3: Start Pilotpraxen

Herausforderungen & Risiken

Risiko	Auswirkung	Mitigation
Dialekte und Sprachvarianz	STT-Fehler bei österr. Dialekten	Hochdeutsch-nahe KI-Sprachführung, Rückfragen, konservative Transkription
Patientenakzeptanz (ältere Zielgruppe)	Ablehnung des KI-Anrufs	Validierung im Pilotbetrieb, Opt-in, empathisches Gesprächsdesign
Lange Sales-Zyklen	Verzögerter Markteintritt	Kostenlose Pilotphase (30–60 Tage), Fokus auf PVE
Einzelgründer	Kapazitätsengpass	Fokussierte Eigenentwicklung, schlanke Kosten, Entwickler ab 2028
Regulatorische Änderungen	Neueinstufung als Medizinprodukt	Klare Zweckbestimmung, kein diagnost. Eingriff, Physician-in-the-loop
Wettbewerber kopieren Voice	Differenzierungsverlust	First-Mover nutzen, Domänenfokus, Wechselkosten durch Integration

Vision & Wachstum

2026

Gründung
MVP-Entwicklung
Abschluss von Pilotpartnerschaften

2027

Pilotbetrieb
Produktverbesserung
Gewinnung erster zahlender Praxen

2028+

Ausbau des Teams
modulare Erweiterung (Facharzt)
DACH-Skalierung

Wachstumsstrategie:

Start in Österreich → Traction aufbauen → Skalierung über wiederkehrende SaaS-Umsätze in den DACH-Raum

Finanzierungspfad:

PreSeed (aws) → Marktvalidierung → Seed-Runde für internationalen Rollout und Teamaufbau

"*Jedes Patientengespräch beginnt besser vorbereitet – strukturierter für die Praxis, zugänglicher und würdevoller für die Patient:innen.*

Quellen

[1] Österreichische Ärztekammer. (2024). Ausbildungsevaluierung 2024: Ärztliche Arbeitszeit und Administrationsbelastung (Auswertung durch ETH Zürich). Wien.

[2] OECD Health Statistics (2023): Konsultationszeiten im internationalen Vergleich. Österreich: Durchschnitt 5 Minuten.

[3] Statistik Austria (2023): IKT-Nutzung in Haushalten. 23 % der über 65-Jährigen ohne regelmäßige Smartphone-Nutzung.

[4] Peterson MC et al. (1992): „Contributions of the history, physical examination and laboratory investigation in making medical diagnoses.“ Western Journal of Medicine, 156(2), 163–165. – 82,5 % Diagnosen via Anamnese.

[5] Lim, J. Y., Kim, Y., Park, J., & Lee, S. (2026). How does medical artificial intelligence revolutionize physician productivity? Yonsei Medical Journal, 67(1). Moura, L., et al. (2025). Hybrid ambient clinical documentation and physician performance. Journal of General Internal Medicine.

[6] Österreichische Ärztekammer (2024): Ärztestatistik – 52.000+ berufsausübende Ärzt:innen in Österreich.

[7] European Commission (2024): European Health Data Space (EHDS) – Regulation Proposal and Factsheet. Brussels.

[8] BMG Österreich (2024): Nationale eHealth-Strategie und Primärversorgungseinheiten (PVEs).

[9] Grand View Research (2023): Voice AI in Healthcare Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2023–2030. San Francisco.

[10] Statista Market Forecast (2024): Digital Health – Austria. Marktvolumen und Segmentierung.

[11] Signify Research (2024): EHR Market Growth Opportunities Across the DACH Region. – SOM-Ableitung Markteintritt.

[12] Irving G. et al. (2017): International Variations in Primary Care Physician Consultation Time. BMJ Open, 7(10).

[13] Österreichische Ärztekammer (2024–2025): Kassenstellenentwicklung und Ärztemangel in Österreich.

[14] Plattform Primärversorgung (2025): PVE-Ausbau in Österreich – Förderstruktur und EU-Mittel.